

表 35 ECMO 每日检查记录单

患者信息					
姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	____岁	床	____床	ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR ☐ VAV
上机时间	____月____日____时	已运行	____天____小时	班次	☐ 白班 ☐ 夜班
A 模块：环路及设备（每班必查）					
检查项目		测量值/状态		预警/异常→处理	
离心泵	声音、异常振动	转速____ RPM		异响/振动→检查泵头是否进气、有无血栓	
血流量	实际流量与显示一致	流量____ L/min		流量骤降→排查前负荷不足、管路扭结、后负荷过大	
跨膜压差	膜前压-膜后压 (mmHg)	膜前____,膜后____, TMP=____		TMP 进行性升高→氧合器凝血预警; $\Delta P > 50$ mmHg 或翻倍→更换氧合器	
氧合器外观	血浆渗漏、血栓、冷凝水	☐ 正常 ☐ 血浆渗漏 ☐ 血栓可见 ☐ 积液		血浆渗漏 氧合器功能下降, 准备更换; 每日轻敲排气口排冷凝水	
管路与接头	无扭结、无松动、无活动性气泡	☐ 正常 ☐ 扭结 ☐ 松动气泡		任何活动性气泡→立即排查进气点, 准备管道钳	
管路颜色	动脉端 (鲜红) / 静脉端 (暗红)	动脉端颜色____ 静脉端颜色____		动脉端变暗→氧合器功能障碍; 静脉端鲜红→再循环过大 (VV) 或南北综合征 (VA)	
变温水箱	水位、水温、报警	水温设定____ ☐ , 实际水温____ ☐		水位过低→补充蒸馏水; 温度异常→检查水箱功能	
空氧混合器	气源连接、流量、FiO ₂	扫气流量____ L/min, FiO ₂ ____ %		气源断开→立即检查氧气/空气接头	
电源	主电源+备用电源正常	☐ 正常 ☐ 仅主电源 ☐ 仅电池		仅电池运行 → 立即插回主电源, 电池续航有限	
手摇泵	主机旁, 功能正常	☐ 在位 ☐ 不在位		不在位→立即找回; 功能异常→更换备用泵	
管道钳	在位且功能正常	☐ 4 把齐全 ☐ 缺少____把		缺→立即补充, 置于醒目固定位置	
报警设置	上下限合理已激活	流量下限____ L/min, 转速上下限____ RPM		报警被静音/关闭→立即重新设置并激活	
B 模块：插管与穿刺点（每班必查）					
检查项目		测量值/状态		预警/异常 → 处理	
插管位置标记：深度刻度是否与记录一致		动脉管____ cm 静脉管____ cm		刻度移位>1cm→警惕脱出/滑入, 超声确认, 通知上级	
插管固定：缝线牢固、扎带固定、无松脱		☐ 牢固 ☐ 松动		松动→重新固定, 操作时注意无菌	
插管处敷：干燥、清洁、无污染		☐ 正常 ☐ 渗湿 ☐ 污染 ☐ 脱落		渗湿/污染→无菌换药; 48-72h 常规更换 (视渗出情况)	
插管处渗血/血肿		☐ 无 ☐ 少量渗血 ☐ 活动性出血 ☐ 血肿		活动性出血→压迫+调整抗凝+通知上级	
下肢灌注 (置管侧)：颜色、皮温、足背动脉搏动		颜色____皮温____ 足背动脉 ☐ 可及 ☐ 弱 ☐ 未及		苍白、冰冷、脉搏消失→紧急评估 DPC 功能, 超声/多普勒检查, 必要时重建血运	
远端灌注导管：正常、无扭结		☐ 在位 ☐ 扭结 ☐ 脱出		DPC 扭结/脱落→紧急处理, 下肢缺血风险高	

置管侧下肢 NIRS (如有)	左 _____% _____ %	右 _____% _____ %	NIRS<50% 或↓>20% 基线→检查灌注, 超声
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------------------

依据: ELSO 指南 (2021-2024) +ELSO 抗凝指南 (2021) +ELSO 神经监测共识 (2024)
+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南(2024) 用途: 每班(白班/夜班)床旁逐项核对, 异常项记录处理措施。